A Consulta Médica em Sete Passos

Fundamentos Epistemológicos, Metodologia Clínica Integrada e Prática Baseada na Pessoa

Autores do Modelo: Prof. Dr. Vítor Ramos e Colaboradores (APMGF / Portugal)	**Abordagem Central:** Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP - Stewart et al.)
Bússola Subjetiva: SIFE (Sentimentos, Ideias, Função e Expectativas)	**Habilidades Comunicacionais:** Referencial Calgary-Cambridge
Documentação Clínica: Prontuário ReSOAP com Lista de Problemas Específica	**Casos Práticos:** 10 Casos Abrangentes de Atenção Primária à Saúde

ROTEIRO TEMÁTICO DAS SEÇÕES DESTE GUIA TÉCNICO:

- **1.** Gênese Histórica e Transição Paradigmática
- **2.** As 3 Fases e os 7 Passos da Consulta em Detalhe
- **3.** Conexão Teórica: MCCP, SIFE e Calgary-Cambridge
- **4.** Raciocínio Clínico na APS e Registro ReSOAP
- **5.** Grelha de Observação Qualitativa (50 Itens)
- **6.** Balanço Crítico, Riscos e Armadilhas Frequentes
- **7.** Matrizes Comparativas e Mapa Mnemônico
- **8.** 10 Casos Clínicos Abrangentes com ReSOAP
- **9.** Considerações Finais: Consulta como Espaço de Cura

A consulta médica constitui o núcleo operatório fundamental da prática clínica e o espaço primordial de produção de cuidado em saúde. Longe de se restringir à aplicação linear de protocolos diagnósticos ou intervenções farmacológicas, o encontro clínico configura um processo interacional humano complexo, no qual se entrelaçam evidências científicas, comunicação interpessoal, valores socioculturais e deliberação compartilhada. Na Atenção Primária à Saúde (APS) e na Medicina Geral e Familiar (MGF) / Medicina de Família e Comunidade (MFC), esse espaço atinge sua expressão máxima, uma vez que as demandas apresentadas raramente se esgotam em categorias exclusivamente biológicas, exigindo o manejo coordenado de dimensões emocionais, familiares e contextuais.

O modelo da Consulta em 7 Passos, concebido e desenvolvido a partir de 2003 no Centro de Saúde de Cascais (Portugal) por Vítor Ramos e colaboradores, sistematizado em livro em 2008 e atualizado criticamente em 2025 por Ramos e Carrapiço na revista Ciência & Saúde Coletiva, foi desenhado para superar as limitações do aprendizado meramente intuitivo da consulta. Ao decompor o encontro clínico em três fases e sete passos dinâmicos, o modelo oferece aos estudantes, residentes e preceptores uma grade reflexiva capaz de estruturar o atendimento sem engessá-lo, articulando de forma indissociável o rigor da técnica biomédica, o Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP), o referencial comunicacional do Guia Calgary-Cambridge e o Registro de Saúde Orientado por Problemas (ReSOAP).

1. Gênese Histórica, Objetivos Pedagógicos e Transição Paradigmática

1.1 Contexto Histórico e Construção Colaborativa

Nos anos iniciais da prática médica, o profissional constrói um "modo de fazer a consulta" que tende a se repetir milhares de vezes ao longo da vida profissional. Historicamente, essa prática consolidava-se de forma acrítica e intuitiva, imitando o comportamento de preceptores mais experientes. Embora referências clássicas da literatura internacional — como as obras seminais de Michael Balint sobre a relação médico-paciente e a farmacologia da própria pessoa do médico, os trabalhos de David Pendleton sobre as tarefas da consulta e os estudos de Francesc Borrell sobre entrevista clínica — fornecessem fundamentos teóricos indispensáveis, preceptores e residentes de Cascais constataram que esses textos eram insuficientes para resolver os desafios pragmáticos enfrentados no cotidiano dos centros de saúde.

Entre 2003 e 2007, desencadeou-se um processo iterativo de cocriação e reflexão crítica sobre o trabalho clínico. A partir da identificação das lacunas sentidas tanto por formadores quanto por formandos, estruturaram-se inicialmente cinco passos fundamentais centrados no momento presencial:

1. Os primeiros minutos;

2. Exploração;

3. Avaliação;

4. Plano;

5. Conclusão/Encerramento.

Ao compartilhar essas fichas formativas em reuniões e workshops com médicos de família de diversas regiões de Portugal, evidenciou-se que a consulta não se iniciava com a entrada do paciente, nem terminava com sua despedida. A consulta é um processo contínuo com antecedentes, desenvolvimento e consequências. Essa percepção levou à incorporação do "Passo 1 – Preparação" (anterior à entrada) e

do "Passo 7 – Reflexão final" (posterior à saída), consolidando a estrutura definitiva das três fases e sete passos, oficializada pela Associação Portuguesa de Médicos de Geral e Familiar (APMGF) em 2008.

1.2 Objetivos de Aprendizado e Metacognição Clínica

A Consulta em 7 Passos foi desenhada como ferramenta pedagógica e reflexiva de autoavaliação, observação por pares e supervisão clínica estruturada. Seus objetivos pedagógicos centrais incluem:

• Desenvolver a competência de estabelecer uma aliança terapêutica sólida desde os primeiros segundos da interação, construindo um ambiente de empatia e confiança indispensável para o exame físico, diagnóstico e coparticipação terapêutica;

• Adquirir a habilidade de escuta atenta e levantamento exaustivo da agenda do paciente, mitigando o fenômeno da interrupção precoce e permitindo a negociação transparente de prioridades;

• Integrar o raciocínio clínico biomédico à exploração da experiência subjetiva do adoecimento através do acrônimo SIFE (Sentimentos, Ideias, Função e Expectativas);

• Capacitar o profissional a compartilhar seu raciocínio diagnóstico e prognóstico em linguagem inteligível e desprovida de jargões técnicos;

• Pactuar planos de cuidados negociados, com metas realistas e definição clara de responsabilidades mútuas, promovendo a capacitação para o autocuidado e incorporando ações de prevenção oportuna;

• Conduzir um encerramento seguro por meio de checagem ativa de compreensão (método *teach-back*) e estabelecimento de rede de segurança (*safety netting*);

• Exercitar a metacognição pós-consulta, promovendo a descontaminação emocional, a autoavaliação de forças e fraquezas e o registro clínico de excelência no prontuário.

1.3 A Transição Paradigmática: Do Reducionismo Flexneriano ao Modelo Clínico Integrado

O modelo tradicional de ensino médico, profundamente ancorado no Relatório Flexner (1910), formatou uma prática clínica mecanicista, hospitalocêntrica e reducionista, na qual o corpo humano é interpretado como uma máquina biológica compartimentada e a doença (*disease*) como uma avaria anatomopatológica independente da subjetividade do hospedeiro. Sob essa ótica, o paciente é transformado em um objeto passivo de estudo e intervenção, cabendo ao médico uma postura inquisitorial, diretiva e prescritiva.

Em contraposição, a Consulta em 7 Passos fundamenta-se no **Modelo Clínico Integrado**, herdeiro direto do modelo biopsicossocial formulado por George Engel em 1977 e do Método Clínico Centrado na Pessoa desenvolvido por Ian McWhinney e Moira Stewart em Ontário. Conforme demonstrado nas reflexões do Tratado de MFC e nos artigos de Vítor Ramos, o Modelo Clínico Integrado adota uma perspectiva ecossistêmica e sistêmica complexa. A saúde e o adoecimento são compreendidos como fenômenos emergentes de teias dinâmicas que conectam processos biológicos, psíquicos, dinâmicas familiares, vínculos comunitários, condições de trabalho e determinantes socioculturais. O encontro clínico deixa de ser a imposição da "agenda do médico" para se converter no encontro genuíno de duas pessoas com saberes legítimos: o médico, detentor do conhecimento técnico-científico e populacional; e o paciente, especialista inquestionável na sua própria vida, no seu sofrimento e no seu contexto singular.

No balanço crítico de 2025, Ramos e Carrapiço ampliam esse referencial para o que denominam ecossistema da atenção à saúde: a consulta não é um evento isolado, mas uma peça dentro de um mosaico muito mais amplo. Desenvolve-se a noção de **Plano Individual de Cuidados (PIC)** e o imperativo da **Autogestão Pessoal de Saúde**, sustentados por um **Prontuário Clínico Pessoal Unificado** e pelo trabalho articulado da equipe multiprofissional próxima e alargada.

---

2. Arquitetura Estrutural da Consulta: As Três Fases e os Sete Passos em Detalhe

A sistematização da consulta médica compreende três fases interdependentes e sete passos operacionais. Embora a organização didática aparente linearidade, a prática clínica na APS é frequentemente não linear e multidirecional — o que os autores denominam estrutura "rizomática" —, exigindo que o médico transite com fluidez entre os passos de acordo com as deixas (*cues*) e necessidades emergentes.

FASE INICIAL Preparação e Entrada	FASE INTERMÉDIA Exploração, Avaliação e Plano (EAP)	FASE FINAL Encerramento e Metacognição
1. Preparação • Checagem do prontuário, pendências, exames e calibração atitudinal interna do médico. **2. Primeiros Minutos** • Acolhimento caloroso, escuta atenta, quebra do gelo e alinhamento de expectativas e agenda.	**3. Exploração (EAP)** • Sintomas objetivos (doença) e vivência da pessoa (SIFE: Sentimentos, Ideias, Função e Expectativas). **4. Avaliação** • Raciocínio clínico integrador, diagnóstico diferencial e encontro de perspectivas. **5. Plano de Cuidados** • Decisão compartilhada, Metas SMART, prevenção quaternária e corresponsabilização.	**6. Encerramento** • Sumarização conjunta, checagem de compreensão (teach-back), rede de segurança e despedida. **7. Reflexão Final** • Registro ReSOAP de alta especificidade, autoavaliação crítica e registro de notas pessoais.

2.1 Fase Inicial: Preparação e Primeiros Minutos

A fase inicial exige investimento consciente em concentração, focalização de energia e preparo do ambiente relacional antes da interação verbal direta.

Passo 1 – Preparação

A preparação ocorre **antes** de o paciente entrar no consultório. O seu propósito primordial é quebrar o automatismo da "consulta em piloto automático", no qual o profissional apenas chama o próximo nome da lista sem presença mental. Desdobra-se em três eixos de checagem:

1. Autoavaliação do Médico (O "Eu Profissional"):

– Avaliação do estado físico: Há necessidade fisiológica premente a satisfazer (água, alimentação, banheiro)? O cansaço físico compromete a acuidade cognitiva?

– Avaliação do estado emocional e descontaminação: Há resíduos afetivos da consulta anterior (frustração, raiva, tristeza por má notícia) contaminando a prontidão para o próximo atendimento?

– Foco no momento presente: Capacidade de silenciar preocupações burocráticas ou pessoais e disponibilizar atenção integral ao próximo indivíduo.

2. Revisão Breve do Prontuário e do Processo Clínico:

– Identificação e personalização: Nome correto, idade, ocupação e como a pessoa prefere ser chamada (nomes sociais, títulos de preferência);

– Contexto familiar e rede de apoio: Genograma breve, fase do ciclo de vida familiar, presença de cuidadores ou lutos recentes;

– Lista de Problemas Ativos: Revisão das condições crônicas diagnosticadas e fatores de risco estratificados;

– Terapêutica habitual vigente: Fármacos em uso contínuo, posologias e histórico de reações adversas;

– Registro SOAP do último contato: Identificação do plano de cuidados acordado anteriormente, metas pactuadas, resultados de exames pendentes e notas prospectivas deixadas para este retorno.

3. Avaliação Sumária do Ambiente do Gabinete:

– Conforto físico: Luminosidade, temperatura adequada e ventilação do espaço;

– Organização e privacidade: Arrumação da mesa, eliminação de papéis desorganizados de outros pacientes (garantindo o sigilo ético), posicionamento das cadeiras para favorecer o contato visual direto sem a barreira rígida da tela do computador;

– Preparação de insumos específicos: Disponibilização prévia de espéculos, esfigmomanômetro calibrado, fita métrica ou formulários necessários.

Passo 2 – Os Primeiros Minutos

Os primeiros minutos definem o clima terapêutico e lançam as bases da aliança relacional. É neste momento que se estabelece a transição da sala de espera para o espaço clínico de acolhimento.

• **Abertura e Cumprimento Inicial:** O médico deve realizar a chamada de forma respeitosa (idealmente indo à porta da sala de espera ou chamando pelo nome correto), estabelecendo contato visual caloroso, aperto de mão ou gesto socialmente adequado, e convidando o paciente e eventuais acompanhantes a se sentarem confortavelmente.

• **Atenção aos Indícios Físicos e Emocionais Imediatos:** Observação da marcha, postura corporal, fácies (expressão de dor, angústia, embotamento ou choro iminente), asseio pessoal, modo de vestir, entonação de voz e a dinâmica relacional com o acompanhante.

• **A Pergunta Aberta Desencadeadora:** Iniciar com perguntas amplas e neutras que confiram protagonismo narrativo: *"Em que posso ajudá-lo hoje?"*, *"O que o trouxe à consulta?"* ou *"Como tem passado desde a nossa última conversa?"*.

• **Ouro Clínico — A Escuta Atenta e Ininterrupta (Os Primeiros 2 Minutos):** Estudos clássicos (como Marvel et al. e Beckman & Frankel) demonstram que os médicos interrompem seus pacientes em média aos 18 a 23 segundos de fala. O Passo 2 exige conter ativamente o "reflexo inquisitorial". Deixar a pessoa falar livremente por cerca de 90 a 120 segundos permite que ela apresente sua narrativa de forma espontânea, revelando a vasta maioria das informações necessárias para a condução do caso.

• **Esgotamento da Lista de Demandas (Prevenção de Demandas Aditivas):** Pacientes frequentemente trazem mais de um motivo de consulta. Quando o médico se apega à primeira queixa mencionada, corre o risco de ser surpreendido no final da consulta com a chamada "síndrome da maçaneta" (*by the way complaint*), quando a preocupação mais grave é finalmente verbalizada. Para esgotar a agenda, utilizam-se técnicas de rastreamento:

• *"Compreendi a dor de cabeça. Além dessa dor, o que mais você gostaria de abordar hoje?"*;

• *"Mais alguma questão que você planejou trazer para o nosso encontro?"*.

• **Negociação e Acerto de Agendas:** Diante de uma multiplicidade de queixas (por exemplo, 4 ou 5 demandas em uma consulta de rotina), médico e paciente realizam uma pactuação transparente do que é prioritário:

• Triagem de gravidade médica (sinais de alarme) versus incômodo prioritário do paciente;

• Lançar mão do atributo da **longitudinalidade**: explicar que as demandas não urgentes são importantes demais para serem tratadas com pressa e agendar consultas subsequentes específicas para abordá-las com a devida profundidade.

2.2 Fase Intermediária: Exploração, Avaliação e Plano (EAP)

A fase intermediária constitui o centro cognitivo e dialógico da consulta, onde as informações subjetivas e objetivas são coletadas, analisadas e transformadas em intervenção terapêutica mútua.

Passo 3 – Exploração, Análise e Contextualização

O objetivo deste passo é apreender a história clínica e a narrativa pessoal sem deformar o "objeto" trazido pelo paciente.

• **Coleta Sistematizada dos Sintomas (Perspectiva Biomédica):** Caracterização detalhada dos sintomas principais — localização, irradiação, qualidade/caráter, intensidade (escalas visuais/numéricas), duração, cronologia de instalação, fatores de melhora e piora, manifestações associadas e resposta a tratamentos prévios.

• **Exploração da Experiência da Doença (Perspectiva Subjetiva):** Investigação intencional dos impactos emocionais, crenças e repercussões na vida diária (desenvolvido através do SIFE).

• **Mapeamento de Fatores de Risco e Determinantes Contextuais:** Hábitos de vida (tabagismo, etilismo, padrão alimentar, atividade física), exposição ocupacional e condições de moradia.

• **Exame Físico Objetivado e Consentido:**

• O exame físico não é um ato mecânico descolado do diálogo; ele possui valor diagnóstico e profundo efeito terapêutico;

• Deve ser precedido de explicação e consentimento: *"Para entender melhor a dor que você descreveu, gostaria de examinar o seu abdome. Tudo bem?"*;

• Durante o exame, o médico deve comunicar o que está fazendo, preservar o pudor da pessoa, atentar para expressões de dor ou desconforto e verbalizar achados de normalidade para tranquilizar o paciente.

• **Síntese Intermediária:** Antes de passar à avaliação, o profissional realiza um breve resumo reflexivo para validar os dados: *"Deixe-me ver se compreendi tudo até aqui: você vem sentindo essa dor há duas semanas, que piora após o trabalho e tem gerado receio de ser um problema grave na coluna. É isso mesmo ou deixei passar algo?"*.

Passo 4 – Avaliação (Raciocínio Clínico e Encontro de Perspectivas)

A avaliação representa o processamento intelectual em que dados dispersos são inter-relacionados para formar um quadro explicativo coerente.

• **Construção do Mapa de Problemas:** Diferenciação entre sintomas isolados, queixas sindrômicas e patologias estabelecidas, estruturando um diagrama que considere multimorbidade, comorbidades e teias causais biopsicossociais.

• **Formulação de Hipóteses Diagnósticas e Raciocínio Dual:** Combinação do raciocínio heurístico/intuitivo (reconhecimento rápido de padrões) com o raciocínio analítico/hipotético-dedutivo para casos atípicos ou complexos.

• **Avaliação de Impactos Funcionais e Prognóstico:** Estimativa de como a condição altera a autonomia, a capacidade de trabalho e a qualidade de vida da pessoa.

• **O "Devolver" Diagnóstico (Compartilhamento da Avaliação):** O médico explica o que está acontecendo utilizando linguagem clara, recorrendo a metáforas apropriadas e evitando terminologias incompreensíveis. O diagnóstico não é imposto como uma sentença técnica, mas apresentado para verificar se a explicação faz sentido para o universo cultural e pessoal daquele indivíduo.

• **Análise SWOT Pessoal Pré-Ação:** Avaliação implícita ou explícita das forças (*strengths*) e fraquezas (*weaknesses*) internas do paciente, combinadas às oportunidades (*opportunities*) e ameaças (*threats*) de sua rede familiar e comunitária, preparando o terreno para a

elaboração de um plano factível.

Passo 5 – Plano de Cuidados e Prevenção

O plano de cuidados traduz a avaliação em ações operacionais negociadas. Um plano imposto de forma autoritária pelo médico resulta em altas taxas de não adesão e frustração relacional.

• **Proposição e Justificação de Exames Complementares:** Todo exame solicitado deve ter finalidade clínica explícita compreendida pelo paciente, discutindo-se previamente o que se espera encontrar e o que será feito com os resultados.

• **Negociação Terapêutica (Farmacológica e Não Farmacológica):**

• Discussão das opções medicamentosas: posologia, duração, custos/disponibilidade no SUS, tempo esperado para início dos efeitos terapêuticos e potenciais efeitos adversos;

• Construção colaborativa de medidas não farmacológicas: mudanças de hábitos alimentares e prática de exercícios adaptados à renda, gostos e tempo da pessoa.

• **Empoderamento e Autogestão:** Transferência progressiva de poder e conhecimento para que o paciente se torne gestor da sua própria saúde (*personal health self-management*).

• **Prevenção Oportunista (O "Já Agora" do Médico):** Identificação de momentos oportunos para intervenções preventivas não relacionadas à queixa principal que motivou a consulta (ex.: atualização do calendário vacinal, rastreamento colpocitológico, cessação tabágica, estratificação de risco cardiovascular), desde que isso não sufoque a agenda da pessoa.

• **Pactuação do Seguimento (*Follow-up*):** Definição clara de quando, como e com quem será a próxima consulta ou contato (médico, enfermeiro da equipe de Saúde da Família, visita domiciliar do Agente Comunitário de Saúde).

2.3 Fase Final: Encerramento e Reflexão Final

A fase final consolida as decisões tomadas, valida a segurança do paciente e promove a aprendizagem profissional contínua.

Passo 6 – Encerramento da Consulta

O encerramento não deve ser uma expulsão apressada do paciente, mas a amarração estruturada do cuidado.

• **Checagem de Compreensão Ativa (Técnica do *Teach-Back*):** Em vez de formular a pergunta passiva *"Você entendeu tudo?"* (à qual quase todos respondem afirmativamente por vergonha), o médico solicita que o paciente verbalize com suas próprias palavras o combinado: *"Para eu ter certeza de que me expliquei com clareza, você poderia me resumir como vai tomar os remédios a partir de amanhã e o que combinamos sobre a caminhada?"*.

• **Esclarecimento de Dúvidas Residuais:** *"Ficou alguma pergunta sem resposta ou algo que não tenha ficado tão claro?"*.

• **Verificação da Satisfação das Expectativas Iniciais:** Checar se a demanda que mais preocupava o paciente no início da consulta foi contemplada satisfatoriamente.

• **Rede de Segurança (*Safety Netting*):** O médico instrui o paciente com precisão sobre:

• A evolução esperada do quadro e o tempo provável para a melhora dos sintomas;

• Quais são os sinais de alarme ou complicações excepcionais que indicam piora;

• O que fazer exatamente, onde procurar atendimento de urgência ou como contatar a equipe da UBS caso esses sinais surjam.

• **Cumprimento Formal de Despedida:** Contato visual, encerramento cordial e acolhimento de eventuais manifestações de afeto e gratidão.

Passo 7 – Reflexão e Notas Finais

Ocorre imediatamente **após** a saída do paciente da sala de atendimento. É o momento dedicado à autorreflexão, completamento dos registros e reorganização psíquica do profissional.

• **Finalização do Registro Clínico (ReSOAP):** Revisão e completamento dos dados inseridos no prontuário eletrônico ou físico, garantindo clareza, brevidade, exatidão e codificação adequada (CIAP-2 / CID-10);

• **Atualização da Lista de Problemas:** Inclusão de novos diagnósticos firmados, inativação de condições resolvidas ou reclassificação de problemas conforme novos achados;

• **Notas Prospectivas ("Lembretes"):** Registro de pontos de atenção e tarefas pendentes a serem checadas na próxima consulta com aquele usuário;

• **Autoavaliação Crítica da Performance:** O que funcionou bem nesta consulta? Onde perdi o foco ou gastei tempo excessivo? Minha postura foi genuinamente empática ou caí no reflexo prescritivo?

• **Identificação de Lacunas Cognitivas:** Reconhecimento de dúvidas clínicas ou farmacológicas que exigem revisão da literatura ou discussão de caso com o preceptor/equipe multiprofissional;

• **Limpeza Mental e Descontaminação Emocional:** Exercício deliberado de respiração e presença para "fechar a gaveta" do caso atendido, descarregando tensões emocionais acumuladas e preparando a mente limpa para acolher o próximo ser humano com a mesma qualidade de atenção.

---

3. Conexão Teórico-Prática: MCCP, SIFE e o Guia Calgary-Cambridge

O modelo da Consulta em 7 Passos não opera em vácuo metodológico. Ele atua como uma esteira operacional que integra harmonicamente as duas maiores referências internacionais em competências clínicas humanizadas: o Método Clínico Centrado na Pessoa e o Guia Calgary-Cambridge.

3.1 Articulação com o Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP)

Na sua formulação clássica e na revisão contemporânea, o MCCP é estruturado em quatro componentes interativos que devem se cruzar continuamente ao longo dos 7 passos:

COMPONENTE 1: Compreensão Integrada da Doença e da Experiência da Pessoa Articulação entre a perspectiva biomédica (sinais objetivos, sintomas e fisiopatologia) e a perspectiva do doente através da bússola subjetiva **SIFE** (Sentimentos, Ideias, Função e Expectativas).
COMPONENTE 2: Entendendo a Pessoa como um Todo Contextualização sistêmica do indivíduo no ciclo de vida pessoal e familiar, rede social de apoio, comunidade, cultura, trabalho e ecossistema.
COMPONENTE 3: Elaborando um Plano Conjunto de Manejo Aliança terapêutica operacional: definição de prioridades compartilhadas, metas realistas (**Metas SMART**), pactuação de papéis e decisão conjunta.
COMPONENTE 4: Intensificando a Relação entre a Pessoa e o Médico Cultivo permanente de empatia acurada, escuta compassiva, aliança terapêutica, confiança e vínculo longitudinal na Atenção Primária.

1. Explorando a Saúde, a Doença e a Experiência da Doença: Diferencia a patologia biológica compartilhada (*disease*) da vivência individual e subjetiva de estar doente (*illness*). Essa exploração é ancorada no Passo 3 e refinada no Passo 4 através do acrônimo SIFE.

2. Entendendo a Pessoa como um Todo: Enxerga o ser humano integrado aos círculos concêntricos do contexto próximo (família, dinâmica doméstica) e distante (trabalho, cultura, determinantes socioeconômicos e espirituais). Alinha-se diretamente aos Passos 1, 3 e 4.

3. Elaborando um Plano Conjunto de Manejo dos Problemas: Consiste no compartilhamento do poder decisório, transformando o paciente de objeto passivo em protagonista corresponsável. Cruza-se diretamente com os Passos 4, 5 e 6.

4. Intensificando a Relação entre a Pessoa e o Médico: Componente transversal e longitudinal presente desde o acolhimento (Passo 2) até a despedida (Passo 6) e reflexão pós-consulta (Passo 7), fortalecendo a confiança, o afeto profissional e a esperança.

3.2 O Acrônimo SIFE como Bússola Subjetiva

A investigação da experiência da doença pelo SIFE é a ferramenta prática que impede que o médico reduza a consulta à catalogação de sinais físicos:

Componente SIFE	Significado Clínico e Dimensão Explorada	Exemplos de Perguntas Disparadoras na Consulta	Impacto na Condução Clínica
S – Sentimentos (*Feelings*)	As emoções despertadas pelo adoecimento, principalmente os medos, ansiedades, culpa, desesperança e sensação de vulnerabilidade.	*"O que mais tem preocupado você em relação a esses sintomas?"* *"Você sentiu medo ou apreensão quando essa dor surgiu?"*	Desarma defesas afetivas, previne a somatização crônica e fortalece o vínculo terapêutico.
I – Ideias (*Ideas / Beliefs*)	As teorias, crenças e explicações formuladas pelo próprio paciente sobre o que está errado com seu corpo.	*"O que você acha ou imagina que possa estar acontecendo?"* *"A que você atribui o surgimento deste problema?"*	Revela crenças errôneas, teorias catastróficas (ex.: medo de câncer) e alinha o diálogo educativo.
F – Função (*Functioning*)	O impacto concreto que a doença e os sintomas causam na vida diária, rotina de trabalho, lazer e relações interpessoais.	*"De que maneira essa dor tem afetado o seu dia a dia?"* *"Você teve que deixar de fazer algo no trabalho ou em casa por causa disso?"*	Mede a incapacidade real percebida, define a prioridade de alívio e guia metas de reabilitação.
E – Expectativas (*Expectations*)	O que o paciente espera que o médico faça, incluindo pedidos implícitos ou explícitos por remédios, exames, encaminhamentos ou apenas escuta.	*"O que você imaginou que poderíamos fazer por você hoje?"* *"Você pensou em algum tratamento ou exame específico ao vir aqui?"*	Evita a frustração mútua, previne exames desnecessários e prepara a tomada de decisão compartilhada.

3.3 Integração com o Guia Calgary-Cambridge

O Guia Calgary-Cambridge sistematiza cerca de 70 habilidades de comunicação clínica divididas em duas grandes tarefas simultâneas: a **estruturação da consulta** e o **desenvolvimento do relacionamento**. O modelo dos 7 Passos incorpora perfeitamente as competências de Calgary-Cambridge ao longo de suas etapas:

• **Iniciando a Sessão (Passo 2 dos 7 Passos):** Estabelecer contato inicial, identificar as razões da consulta com perguntas abertas, ouvir a declaração inicial sem interrupção e negociar a agenda de trabalho;

• **Reunindo Informações (Passo 3 dos 7 Passos):** Explorar a perspectiva do paciente em paralelo à perspectiva biomédica, utilizar facilitação verbal/não verbal, pausas reflexivas e checagem de linguagem corporal;

• **Fornecendo Estrutura (Passos 2 a 5):** Tornar a organização visível através de sinalização (*signposting*) e sumários periódicos (*"Agora que terminamos de conversar sobre a dor no estômago, gostaria de passar para a verificação da sua pressão, tudo bem?"*);

• **Construindo o Relacionamento (Transversal - Passos 2 a 6):** Demonstrar comportamento não verbal empático, expressar acolhimento, validar sentimentos e adotar uma postura de colaboração e parceria;

• **Explicação e Planejamento (Passos 4 e 5):** Fornecer a quantidade e o tipo corretos de informação em pequenos blocos (*chunk and check*), incentivar perguntas, incorporar a perspectiva da pessoa e negociar decisões mutuamente aceitáveis;

• **Fechando a Sessão (Passo 6):** Resumir os passos acordados, checar segurança através da rede de proteção (*safety net*) e estabelecer o contrato de acompanhamento.

---

4. O Raciocínio Clínico na Consulta da APS e o Registro ReSOAP

4.1 A Especificidade do Raciocínio Clínico na Atenção Primária

O raciocínio clínico na APS distingue-se fundamentalmente do raciocínio hospitalar ou de pronto-socorro. Conforme demonstrado nos estudos de Norbert Donner-Banzhoff e no Tratado de MFC, o médico de família atua em um cenário de **baixa prevalência de doenças graves e alta prevalência de condições indiferenciadas, sintomas precoces e problemas psicossociais**.

• **Prevalência e Teorema de Bayes:** A probabilidade pré-teste na APS é baixa para agravos raros. Exames subsidiários aplicados indiscriminadamente geram uma enxurrada de falsos-positivos e sobrediagnósticos iatrogênicos.

• **As Três Estratégias Iniciais de Abertura:** Médicos experientes na APS utilizam a abertura da consulta para construir uma narrativa sólida que estimule o protagonismo do paciente e permita levantar dados-chave para cenários diagnósticos, prognósticos e terapêuticos.

• **O Tempo e a Longitudinalidade como Recursos Diagnósticos:** Ao contrário da urgência, na APS o médico dispõe do recurso clínico da **"demora permitida"** (espera vigilante assistida). Em sintomas inespecíficos sem sinais de alarme (*red flags*), adiar investigações invasivas e reavaliar o paciente em 1 a 2 semanas frequentemente permite que a história natural da doença se defina ou que o sintoma se resolva espontaneamente.

4.2 O Registro de Saúde Orientado por Problemas (ReSOAP)

Desenvolvido por Lawrence Weed na década de 1960 como Registro Médico Orientado por Problemas (RMOP) e adaptado na APS brasileira como Registro de Saúde Orientado por Problemas (ReSOAP), este método é mais do que uma forma de anotação: é a tradução gráfica do próprio raciocínio clínico centrado na pessoa.

• **Mais do que a "Foto", o "Filme":** O registro hospitalar tradicional captura apenas um episódio agudo isolado (uma foto). O ReSOAP na APS estrutura o prontuário como um filme contínuo, no qual cada consulta é um fotograma conectado à história pregressa e prospectiva daquele ser humano.

• **Estrutura das Notas de Evolução (SOAP):**

• **S (Subjetivo):** O relato do paciente nas suas próprias palavras, incluindo a queixa principal, o histórico narrativo, sintomas associados, o contexto biopsicossocial e a exploração explícita do SIFE.

• **O (Objetivo):** Dados observáveis pelo profissional — sinais vitais, antropometria, achados do exame físico geral e segmentar focado no problema, resultados de exames laboratoriais/gráficos checados e notas sobre o afeto e a comunicação não verbal.

• **A (Avaliação):** O núcleo do julgamento clínico. Deve ser formulada **no mais alto grau de especificidade possível no momento** (ex.: "Cefaleia tensional episódica", "Hipotireoidismo primário compensado", "Luto recente", "Uso nocivo de álcool" ou "Perda de peso a esclarecer"). **Erros a evitar:** termos vagos, categorias administrativas ("consulta de rotina", "paciente veio buscar receita") ou suposições laboratoriais provisórias como se fossem o problema ativo.

• **P (Plano):** O contrato de conduta pactuado entre médico e paciente, estruturado sistematicamente em quatro componentes:

1. *Plano Diagnóstico:* Exames a solicitar ou observação assistida;

2. *Plano Terapêutico:* Prescrições farmacológicas e acordos de intervenção comportamental/estilo de vida;

3. *Plano de Acompanhamento / Seguimento:* Prazos pactuados de retorno, envolvimento da equipe multiprofissional (eNASF/enfermagem) e critérios da rede de segurança;

4. *Plano Educativo / Emancipatório:* Orientações de autocuidado, desmistificação de crenças e checagem de compreensão.

5. Instrumentos de Avaliação: Grelha de Observação Qualitativa da Consulta

A avaliação formativa de consultas requer ferramentas padronizadas para transformar o encontro clínico em um objeto pedagógico analisável. No modelo de Vítor Ramos, sistematizou-se a Grelha de Observação Qualitativa Sumária, estruturada em 50 itens avaliados de forma dicotômica ou formativa:

Passo da Consulta	Focos Observacionais e Competências Avaliadas na Grelha (Itens 1 a 50)
Passo 1: Preparação	Atenção à situação do médico e gabinete; personalização do próximo utente; contexto familiar e sócio-ocupacional; resumo e lista de problemas; medicação habitual; anotações e SOAP da última consulta; identificação de omissões e lembretes prévios.
Passo 2: Primeiros Minutos	Observação atenta e cumprimento inicial; identificação de indícios físicos/emocionais; motivo expresso inicial; motivos adicionais; rastreamento de motivos latentes ("ocultos"); ideias e expectativas; lembrança de alertas do Passo 1.
Passo 3: Exploração	Caracterização de sintomas de alto valor preditivo; emoções, sentimentos e pontos de vista; repercussões na qualidade de vida e função; fatores de risco; preparação e consentimento para exame físico; exame objetivo focado; síntese intermediária.
Passo 4: Avaliação	Avaliação sucinta e informação ao paciente; lista/mapa de problemas; exploração de crenças e explicações do paciente; explicação compreensível pelo médico; encontro de agendas; dados prognósticos; impacto na funcionalidade; balanço SWOT pré-ação.
Passo 5: Plano	Justificação de exames auxiliares; medidas não farmacológicas; prescrição farmacológica explicada; negociação e envolvimento do paciente; metas compartilhadas; capacitação e empoderamento; plano de follow-up; prevenção oportunista (*"já agora"*).
Passo 6: Encerramento	Confirmação de clareza e compreensão (*teach-back*); exploração de dúvidas residuais; confirmação do esgotamento da agenda; recapitulação das ações; encerramento formal caloroso.
Passo 7: Reflexão Final	Registros efetuados e completamento do ReSOAP; identificação de pontos fortes da consulta; identificação de pontos fracos no desempenho médico; aspectos a melhorar; retenção do aprendizado essencial; notas prospectivas para a próxima consulta.

6. Balanço Crítico, Armadilhas Frequentes e Estratégias de Superação

Quinze anos após a edição original de 2008, o balanço publicado por Ramos e Carrapiço (2025) aponta para os perigos de uma apropriação tecnicista do método dos 7 Passos, estabelecendo alertas e correções práticas fundamentadas na experiência de formação médica:

Passo da Consulta	Armadilhas e Vícios de Prática Comuns	Consequências Negativas	Estratégia de Superação e Boa Prática
Passo 1 (Preparação)	Pular a preparação para "ganhar tempo"; chamar o paciente enquanto digita no computador sobre a consulta anterior; gabinete desorganizado.	Atendimento despersonalizado; contaminação emocional negativa; perda de alertas de segurança do prontuário.	Pausa deliberada de 1 minuto entre consultas; autoavaliação mental; leitura focada da lista de problemas e notas prospectivas.
Passo 2 (Primeiros Minutos)	Interromper precocemente a fala do paciente (antes de 30 segundos); focar na primeira queixa e ignorar a lista de demandas.	Demanda oculta surgindo na maçaneta ao final da consulta; atraso da agenda; quebra da confiança inicial.	Escuta atenta sem interrupção por até 2 minutos; técnica de rastreamento (*"Além disso, algo mais?"*); pactuação explícita de prioridades.
Passo 3 (Exploração)	Fazer apenas perguntas fechadas em formato inquisitorial; não explorar o SIFE; realizar exame físico descolado da conversa.	Visão puramente mecanicista da queixa; não identificação de angústias e medos; aumento de pedidos de exames inúteis.	Transição suave de perguntas abertas para fechadas; exploração ativa do SIFE; exame físico consentido, explicado e humanizado.
Passo 4 (Avaliação)	Guardar o raciocínio clínico para si; usar jargões incompreensíveis; rotular o paciente sem validar suas crenças.	Paciente sai confuso, ansioso ou discordando do diagnóstico; baixa adesão ao plano de tratamento.	"Devolver" a avaliação em linguagem clara e acessível; verificar se a explicação faz sentido para a pessoa; acolher divergências.
Passo 5 (Plano)	Impor uma conduta de cima para baixo ("faça isso e tome aquilo"); ignorar barreiras financeiras ou culturais; esquecer a prevenção.	Não adesão terapêutica; abandono do tratamento; sentimento de impotência e desresponsabilização do paciente.	Tomada de decisão compartilhada; oferta de opções de escolha; metas SMART pactuadas; prevenção oportunista (*"já agora"*).

Passo da Consulta	Armadilhas e Vícios de Prática Comuns	Consequências Negativas	Estratégia de Superação e Boa Prática
Passo 6 (Encerramento)	Encerrar abruptamente com pergunta passiva (*"Alguma dúvida?"*); não estabelecer rede de segurança com critérios de alerta.	Paciente retorna à emergência por dúvidas simples ou descompensa em casa sem saber identificar sinais de piora.	Aplicação do método *Teach-back*; confirmação ativa de satisfação da agenda; rede de segurança clara com prazos e sinais de alarme.
Passo 7 (Reflexão Final)	Levantar-se e chamar imediatamente o próximo paciente sem registrar ou refletir; acumular prontuários para preencher no fim do dia.	Registros clínicos incompletos e omissos; esgotamento mental (*burnout*); perda de oportunidades preciosas de aprendizado clínico.	Registro imediato do SOAP; atualização da lista de problemas; notas prospectivas; breve "limpeza mental" para zerar as tensões.

6.1 O Risco da Rigidez Tecnológica e a Perda da Espontaneidade

O método dos 7 passos é uma proposta de trabalho e treinamento didático; nunca deve se tornar uma camisa de força. A tentativa de forçar um paciente a seguir estritamente a ordem numérica dos passos contra a sua vontade destrói a própria essência do Método Clínico Centrado na Pessoa. A maestria clínica reside em manter uma disciplina estrutural interna enquanto se preserva a máxima abertura externa, flexibilidade e acolhimento à narrativa espontânea do ser humano.

7. Matrizes e Tabelas de Síntese para Memorização Rápida

7.1 Matriz Comparativa Tridimensional: 7 Passos x MCCP x Calgary-Cambridge

Fase da Consulta	Passo do Modelo 7 Passos	Componente Correspondente do MCCP	Etapa do Guia Calgary-Cambridge	Foco Operacional Dominante
Fase Inicial	**1. Preparação**	Entendendo a Pessoa como um Todo (Contexto Prévio)	Preparação Inicial (Pré-consulta)	Autoavaliação do médico, revisão de prontuário e prontidão do ambiente.
Fase Inicial	**2. Primeiros Minutos**	Intensificando a Relação Médico-Pessoa	Iniciando a Sessão	Acolhimento, escuta ininterrupta, esgotamento e negociação da agenda.
Fase Intermédia	**3. Exploração**	Explorando a Saúde, Doença e Experiência (SIFE)	Reunindo Informações	Anamnese profunda, busca do SIFE, contexto social e exame físico focado.
Fase Intermédia	**4. Avaliação**	Compreensão Integrada / Encontro de Agendas	Fornecendo Estrutura / Diagnóstico Compartilhado	Raciocínio clínico compartilhado, devolução inteligível e mapa de problemas.
Fase Intermédia	**5. Plano**	Elaborando um Plano Conjunto de Manejo	Planejamento: Decisão Compartilhada	Negociação terapêutica, metas SMART, empoderamento e prevenção.
Fase Final	**6. Encerramento**	Intensificando a Relação / Compromisso Mútuo	Concluindo a Sessão	Checagem por *Teach-back*, rede de segurança e despedida formal calorosa.
Fase Final	**7. Reflexão Final**	Aperfeiçoamento Contínuo da Prática	Revisão Metacognitiva Pós-Consulta	Registro ReSOAP completo, notas prospectivas e descontaminação emocional.

7.2 O Mapa Mnemônico da Consulta em 7 Passos

Para retenção cognitiva rápida durante o atendimento clínico, o médico pode visualizar mentalmente as seguintes palavras-chave em cada passo:

1. PREPARAR: Eu, o prontuário e o consultório.

2. CONECTAR: Acolher, ouvir sem cortar e mapear a lista completa de queixas.

3. EXPLORAR: Sintoma biomédico + SIFE (sentimento, ideia, função, expectativa) + exame físico.

4. COMPREENDER: Raciocinar, nomear o problema e devolver a explicação em linguagem humana.

5. PACTUAR: Construir o plano a quatro mãos, com metas realistas e prevenção oportuna.

6. SEGURAR: Checar entendimento (*teach-back*), traçar rede de segurança e despedir.

7. APRENDER: Registrar no SOAP, atualizar problemas, respirar e limpar a mente.

8. Dez Casos Clínicos Abrangentes com Aplicação Prática dos Sete Passos

Os casos clínicos a seguir foram estruturados para demonstrar a aplicação pragmática e fidedigna das três fases e dos sete passos da consulta médica em cenários representativos da Atenção Primária à Saúde, ilustrando a transição dinâmica da narrativa clínica para a Lista de Problemas e o Plano Conjunto no modelo ReSOAP.

Caso Clínico 1: A Agenda Oculta e a Demanda da Maçaneta na APS

• **Cenário:** Dona Mercedes, 52 anos, diarista, comparece à UBS agendada formalmente para "renovação de receita de hidroclorotiazida".

Aplicação dos 7 Passos:

1. Passo 1 (Preparação): O médico de família confere o prontuário: hipertensa há 6 anos, último contato há 8 meses com PA controlada (124/82 mmHg), mãe falecida por acidente vascular encefálico. Médico respira fundo, checa se a sala está privativa e afasta o teclado da linha de visão direta.

2. Passo 2 (Primeiros Minutos): Chama Dona Mercedes na porta, cumprimenta-a com caloroso contato visual. Abre com pergunta ampla: *"Dona Mercedes, que bom revê-la. Em que posso ajudá-la hoje?"*. A paciente responde: *"Doutor, vim só renovar minha receita da pressão que acabou"*. O médico utiliza a técnica de esgotamento de agenda: *"Perfeito, vamos acertar a receita sim. Mas me diga: além da receita, há mais alguma coisa que tem incomodado a senhora ou que gostaria de conversar hoje?"*. Dona Mercedes silencia por 5 segundos, desvia o olhar e mareja os olhos: *"Na verdade, doutor... tenho sentido um aperto horrível no peito toda noite quando deito"*. Agenda pactuada: dor no peito/angústia noturna como prioridade, seguida da revisão da hipertensão.

3. Passo 3 (Exploração): Exploração da dor: desconforto precordial em aperto, sem irradiação, não relacionado ao esforço físico, ocorrendo quando se deita, acompanhado de sensação de sufocamento e insônia. Investigação do SIFE:

– *Sentimentos:* Pavor de morrer de repente durante a noite.

– *Ideias:* Acha que seu coração está falhando igual ao da mãe que morreu de AVC.

– *Função:* Não consegue dormir direito, chega exausta ao trabalho de diarista, temendo perder os clientes.

– *Expectativas:* Esperava que o médico fizesse um eletrocardiograma e dissesse se ela está enfartando.

– *Exame Físico:* PA = 130/80 mmHg, FC = 76 bpm, ritmo regular, ausculta cardiopulmonar e palpação da parede torácica sem alterações.

4. Passo 4 (Avaliação): O médico explica que o exame físico e os sintomas não apontam para obstrução nas artérias do coração ou infarto agudo, associando o aperto à sobrecarga emocional e ansiedade desencadeada pelo aniversário de um ano da morte da mãe. Dona Mercedes suspira aliviada: *"Eu tinha certeza de que meu coração estava parando"*.

5. Passo 5 (Plano de Cuidados):

– Pactuação de medidas não farmacológicas: técnicas de higiene do sono e exercícios respiratórios ao deitar;

– Avaliação conjunta sobre apoio emocional no grupo de mulheres da UBS;

– Manutenção da hidroclorotiazida 25 mg/dia;

– Prevenção oportunista: checagem da mamografia (em dia) e agendamento de citopatológico de colo uterino pendente.

6. Passo 6 (Encerramento):

– *Teach-back: "Dona Mercedes, o que ficou combinado sobre o que fazer quando o aperto surgir à noite?"* Paciente explica a respiração e a certeza de que seu coração está são.

– *Rede de segurança:* Orientada de que se a dor mudar de padrão — surgir em aperto forte ao subir ladeiras ou irradiar para o braço com suor frio —, deve procurar o pronto atendimento imediatamente. Retorno programado em 4 semanas.

7. Passo 7 (Reflexão Final): Registro minucioso no prontuário; atualização da lista de problemas; reflexão médica sobre como a consulta teria fracassado e mantido a paciente em sofrimento caso o médico tivesse apenas impresso a receita em 3 minutos.

Registro ReSOAP:

• **S:** Diarista, 52 anos. Queixa inicial de renovação de receita de anti-hipertensivo. Ao esgotar agenda, relata aperto precordial atípico noturno há 3 semanas, associado a insônia e choro fácil. SIFE: S- Medo intenso de infarto fulminante; I- Acha que tem a mesma doença fatal da mãe; F- Fadiga no trabalho doméstico; E- Pede avaliação cardíaca.

• **O:** Bom estado geral, corada. PA = 130/80 mmHg, FC = 76 bpm. Ausculta cardíaca normal em 2 tempos, sem sopros. Ausculta pulmonar limpa.

• **A:**

1. Transtorno de ansiedade reativo / Luto recente mal elaborado;

2. Hipertensão Arterial Sistêmica compensada;

3. Prevenção ginecológica oportuna pendente.

• **P:**

• *Terapêutico:* Manter hidroclorotiazida 25 mg 1x/dia pela manhã. Iniciar diário do sono e técnicas de desaceleração noturna. Ofertar acolhimento psicológico/eNASF.

• *Diagnóstico:* Eletrocardiograma de repouso na UBS para tranquilização informada.

• *Seguimento:* Retorno agendado para 4 semanas na UBS.

• *Educativo/Rede de Segurança:* Esclarecida a natureza não coronariana da dor e orientados sinais de alarme cardíaco agudo. Coleta de colpocitologia agendada com a enfermagem.

Caso Clínico 2: A Demanda Exigente e o Conflito de Agendas na Dor Lombar Aguda

• **Cenário:** Seu Carlos, 38 anos, estoquista em rede atacadista, entra na sala com postura tensa e exige de imediato: *"Doutor, travei a coluna ontem pegando peso. Preciso que o senhor peça uma ressonância magnética agora e me dê 15 dias de atestado!"*.

Aplicação dos 7 Passos:

1. Passo 1 (Preparação): O médico nota o histórico: 38 anos, trabalhador braçal, sem histórico de neoplasia ou comorbidades crônicas, sem consultas recentes. Médico prepara-se para não responder à agressividade ou exigência com reatividade (contenção emocional).

2. Passo 2 (Primeiros Minutos): Cumprimenta o paciente com respeito, mantém contato visual sereno e valida a situação antes de discutir o pedido: *"Seu Carlos, vejo que o senhor está com muita dor e visivelmente incomodado para andar. Vamos sentar com calma. Quero ouvir detalhadamente o que houve e examinar sua coluna para definir o melhor tratamento para o senhor"*. O médico desarma a exigência sem confrontá-la diretamente.

3. Passo 3 (Exploração): Início súbito da dor após carregar caixa de 30 kg no trabalho há 24h. Dor lombar baixa bilateral em queimação e pontada, sem irradiação para membros inferiores, sem perda de força motora, sem febre e sem perda de controle de esfíncteres (ausência de sinais de alarme / *red flags*). SIFE:

– *Sentimentos:* Raiva pelo acidente de trabalho e pânico de ter tido uma "hérnia de disco definitiva" que o impeça de sustentar os filhos.

– *Ideias:* Acha que o osso da coluna saiu do lugar e que só uma ressonância magnética pode "mostrar a fratura".

– *Função:* Impossibilitado de carregar peso ou ficar muito tempo sentado.

– *Expectativas:* Exigência inicial de ressonância e afastamento prolongado.

– *Exame Físico:* Marcha antálgica sem claudicação neurológica. Espasmo paravertebral lombar palpável com dor à flexão anterior do tronco. Teste de elevação da perna estendida (Lasègue) negativo bilateralmente. Força muscular e reflexos patelares/aquileus preservados (Grau V bilateral).

4. Passo 4 (Avaliação): Encontro de agendas e compartilhamento do raciocínio: o médico explica que o exame físico neurológico minucioso afasta qualquer compressão de nervo ou fratura, tratando-se de uma lombalgia mecânica aguda por estiramento muscular e ligamentar. O médico explica tecnicamente por que a ressonância não está indicada: a maioria das pessoas sem dor tem pequenas alterações degenerativas que, se vistas na imagem, geram cirurgias desnecessárias e pioram a dor por medo (iatrogenia da imagem).

5. Passo 5 (Plano de Cuidados):

– Negociação da conduta: Prescrição de anti-inflamatório por tempo curto (máximo 5 dias) associado a analgésico simples e calor local;

– Contraindicação de repouso absoluto no leito (estimular caminhadas leves conforme tolerância);

– Negociação responsável do atestado: pactuados 3 dias de afastamento inicial para fase álgica aguda, com reavaliação no final da semana;

– Orientação ergonômica de postura para levantamento de cargas.

6. Passo 6 (Encerramento):

– *Teach-back:* Checado se o paciente compreendeu que caminhar é melhor do que ficar na cama imóvel.

– *Rede de segurança:* Alertado sobre febre, dormência em sela ou perda de força nas pernas como sinais para retorno imediato.

7. Passo 7 (Reflexão Final): O médico anota o ReSOAP, reconhecendo em sua reflexão como foi difícil conter o impulso inicial de discutir ou ceder passivamente ao pedido do exame, sentindo-se satisfeito com a construção do acordo negociado.

Registro ReSOAP:

• **S:** Estoquista, 38 anos. Dor lombar súbita há 24h após levantamento de carga de 30 kg. Nega irradiação para pernas, queixas urinárias ou febre. SIFE: S- Ansiedade e medo de invalidez permanente; I- Crença de "osso quebrado" ou hérnia grave; F- Incapaz de estocar mercadorias; E- Pedia ressonância de urgência e 15 dias de licença.

• **O:** Dor à palpação de musculatura paravertebral lombar L3-L5. Lasègue negativo bilateral a 80º. Reflexos aquileu e patelar normais e simétricos (+2/+2). Força preservada em L4, L5 e S1.

• **A:** Lombalgia mecânica aguda ocupacional sem sinais de alarme neurológico.

• **P:**

• *Terapêutico:* Ibuprofeno 400 mg VO 8/8h por 3 a 5 dias + Dipirona 1 g se dor. Compressas mornas locais. Orientado repouso relativo ativo (evitar imobilização em cama). Atestado médico de 3 dias emitido.

• *Diagnóstico:* Ausência de critérios clínicos para solicitação de exames de imagem no momento.

• *Seguimento:* Retorno em 3 dias se não houver melhora álgica substancial.

• *Rede de segurança:* Orientados sinais de alerta neurológico (parestesias, perda de força, disfunção esfincteriana).

Caso Clínico 3: Multimorbidade e a Sobrecarga de Doenças no Idoso Frágil

• **Cenário:** Seu Benedito, 74 anos, aposentado, hipertenso, diabético e portador de osteoartrite de joelhos, comparece acompanhado pela filha Maria.

Aplicação dos 7 Passos:

1. Passo 1 (Preparação): O médico de família consulta o histórico: uso de 7 medicamentos diários (polifarmácia), internação há 4 meses por hipoglicemia, viúvo recente. Prepara-se para um atendimento que envolva o paciente e a filha sem anular a autonomia do idoso.

2. Passo 2 (Primeiros Minutos): O médico recebe ambos, mas direciona o olhar e a fala primária a Seu Benedito: *"Seu Benedito, muito bom dia! Como o senhor está passando?"*. Quando a filha tenta responder pelo pai, o médico acolhe a filha com um sorriso e gentilmente devolve o protagonismo ao idoso: *"Dona Maria, já quero ouvir muito suas observações, mas me permita ouvir primeiro do Seu Benedito o que ele está sentindo"*. Agenda pactuada: tonturas recentes e dores nos joelhos.

3. Passo 3 (Exploração): Tonturas ao levantar da cama e fraqueza pela manhã, com medo de sofrer quedas. Filha relata que o pai quase caiu na cozinha duas vezes nesta semana. SIFE:

– *Sentimentos:* Tristeza e medo de perder a independência e ir para um asilo.

– *Ideias:* Acha que a tontura é "labirintite da velhice".

– *Função:* Parou de ir até a padaria comprar pão matinal.

– *Expectativas:* Queria um remédio novo para labirintite.

– *Exame Físico:* PA deitado = 142/84 mmHg; PA em pé (após 3 minutos) = 112/68 mmHg (queda da PAS > 20 mmHg = Hipotensão Ortostática documentada). Glicemia capilar = 138 mg/dL.

4. Passo 4 (Avaliação): O médico explica de forma simples que a tontura não é labirintite, mas sim uma queda rápida da pressão ao levantar, provocada pelo acúmulo de remédios da pressão e relaxantes que o idoso vinha tomando. Mapeia a síndrome de polifarmácia inapropriada e risco elevado de quedas.

5. Passo 5 (Plano de Cuidados):

– Desprescrição compartilhada: suspensão gradual do vasodilatador periférico e redução da dose do betabloqueador;

– Prescrição comportamental: orientação para sentar na beira da cama por 2 minutos antes de ficar em pé, hidratação adequada ao acordar;

– Fisioterapia da UBS para fortalecimento de membros inferiores;

– Prevenção: revisão ambiental domiciliar (retirar tapetes soltos e instalar barras no banheiro).

6. Passo 6 (Encerramento):

– *Teach-back:* Seu Benedito explica como vai levantar da cama devagar e quais remédios foram retirados da caixinha pela filha.

– *Rede de segurança:* Se apresentar desmaio ou vertigem rotatória mantida, retornar de imediato. Retorno agendado em 14 dias.

7. Passo 7 (Reflexão Final): O médico registra o ReSOAP, atualiza a lista de medicamentos ativos no sistema informatizado e reflete sobre como a mediação sensível entre o paciente idoso e o familiar cuidador evitou uma internação futura por fratura de fêmur.

Registro ReSOAP:

• **S:** Aposentado, 74 anos, comparece com a filha. Queixa de tontura matinal e desequilíbrio ao levantar há 10 dias. Nega síncope, mas houve dois episódios de quase queda. Em uso de Losartana 50mg, Anlodipino 10mg, Atenolol 50mg, Metformina 850mg, Glibenclamida 5mg e Ciclobenzaprina 10mg. SIFE: S- Medo de institucionalização e perda de autonomia; I- Acha que tem labirintite; F- Deixou de fazer caminhadas e compras; E- Pede remédio para tontura.

• **O:** Lúcido, orientado. PA deitado: 142/84 mmHg, FC: 58 bpm. PA em pé (3 min): 112/68 mmHg, FC: 62 bpm. Marcha senil cautelosa. Sem déficits focais.

• **A:**

1. Hipotensão ortostática iatrogênica secundária a polifarmácia anti-hipertensiva;

2. Risco elevado de quedas no idoso frágil;

3. Diabetes Mellitus tipo 2 e Osteoartrite crônica estáveis.

• **P:**

• *Terapêutico:* Desprescrição: Suspender Ciclobenzaprina. Reduzir Anlodipino para 5 mg/dia e suspender Atenolol progressivamente. Manter Losartana e hipoglicemiantes.

• *Educativo:* Manobras posturais lentas ao levantar; aumento da ingestão hídrica matinal; orientações à filha sobre eliminação de riscos domiciliares (tapetes).

• *Seguimento:* Retorno em 14 dias para reavaliação pressórica e controle glicêmico.

• *Rede de segurança:* Buscar a UBS se registrar síncope, dor no peito ou glicemias < 70 mg/dL.

Caso Clínico 4: Abordagem do Tabagismo e Ambivalência em Paciente Resistente

• **Cenário:** Seu Osmar, 58 anos, pedreiro, hipertenso e tabagista de 40 maços-ano, comparece arrastado pela esposa para "fazer um check-up".

Aplicação dos 7 Passos:

1. Passo 1 (Preparação): O médico de família checa: fuma desde os 18 anos, não comparece à unidade há 3 anos, último registro apontava PA limítrofe. O médico prepara-se para acolher um paciente que não procurou o serviço por vontade própria, evitando posturas punitivas ou sermões morais.

2. Passo 2 (Primeiros Minutos): Cumprimento amigável. O médico percebe que Osmar está de braços cruzados e calado: *"Seu Osmar, seja muito bem-vindo. Percebo que o senhor veio acompanhando sua esposa. Como o senhor se sente estando aqui hoje?"*. Osmar desabafa: *"Doutor, vim porque ela não me dá paz, dizendo que vou morrer porque fumo. Mas eu trabalho duro e não sinto nada!"*. O médico acolhe a fala sem repreender: *"Entendo perfeitamente, Seu Osmar. Ninguém gosta de ser obrigado a nada. Hoje não vou mandar o senhor parar de fazer nada; quero apenas conhecê-lo e ver como está sua saúde"*.

3. Passo 3 (Exploração): Exploração aberta de hábitos de vida e sintomas respiratórios. Relata tosse matinal com pigarro que ele atribui à "poeira da obra".

– *SIFE (em relação ao fumo):*

– *Sentimentos:* Irritação com a cobrança familiar; apego ao cigarro como companheiro no final do dia.

– *Ideias:* Acha que parar de fumar depois dos 50 anos não adianta mais nada.

– *Função:* Fôlego curto para subir no andaime, precisando parar para descansar.

– *Expectativas:* Esperava levar uma bronca do médico e ser obrigado a tomar remédios caros.

– *Exame Físico:* PA = 148/92 mmHg, murmúrio vesicular universalmente reduzido com tempo expiratório discretamente prolongado.

4. Passo 4 (Avaliação): O médico mapeia o estágio motivacional: **Contemplação inicial / Pré-contemplação**. Em vez de confrontar, utiliza a Entrevista Motivacional e a exploração de discrepâncias: *"O senhor me disse que seu maior orgulho é ser o mestre de obras que sobe em qualquer laje com agilidade. Como o cansaço que o cigarro causa combina com esse seu orgulho daqui a 5 anos?"*. Seu Osmar reflete: *"É... no último mês meus ajudantes tiveram que carregar os sacos de cimento porque minhas pernas pesaram"*.

5. Passo 5 (Plano de Cuidados):

– Não imposição do "Dia D" de parada imediata;

– Aplicação da Balança Decisional: paciente levará para casa uma folha para anotar os prós e contras de fumar versus parar;

– Pactuação de redução de danos inicial (não fumar dentro de casa e atrasar o 1º cigarro do dia em 1 hora);

– Prescrição de Enalapril 10 mg 12/12h para a hipertensão confirmada.

6. Passo 6 (Encerramento):

– *Teach-back:* Checagem sobre o uso do anti-hipertensivo e o acordo de não levar sermão para casa.

– *Rede de segurança:* Apresentado o grupo de apoio ao tabagismo da unidade para quando ele sentir curiosidade de conhecer. Retorno em 30 dias.

7. Passo 7 (Reflexão Final): O médico anota o ReSOAP, valorizando em suas notas como resistir ao "reflexo de endireitamento" manteve o paciente vinculado ao serviço, transformando uma consulta potencialmente hostil em uma porta aberta para a mudança futura.

Registro ReSOAP:

• **S:** Pedreiro, 58 anos, comparece sob pressão conjugal. Assintomático cardiovascular, refere tosse matinal e dispneia leve aos grandes esforços. Tabagista de 30 cig/dia há 40 anos (60 maços-ano). SIFE: S- Ressentimento com cobranças da esposa; I- Crença de dano irreversível inútil de tratar; F- Queda de rendimento no canteiro de obras; E- Esperava sermão médico.

• **O:** Bom estado geral, dentes amarelados. PA = 148/92 mmHg (confirmada em 3 medidas). Ausculta pulmonar com murmúrio diminuído globalmente. Ausculta cardíaca normal.

• **A:**

1. Hipertensão Arterial Sistêmica estágio 1 descompensada;

2. Tabagismo pesado (Fagerström 8) em transição Pré-contemplação / Contemplação;

3. Suspeita clínica de DPOC inicial.

• **P:**

• *Terapêutico:* Iniciar Maleato de Enalapril 10 mg VO 12/12h. Abordagem motivacional centrada na autoeficácia: pactuada meta de não fumar no quarto e postergar o primeiro cigarro da manhã.

• *Diagnóstico:* Solicitar espirometria pós-broncodilatador e exames laboratoriais de rotina de hipertensão.

• *Seguimento:* Retorno em 4 semanas para revisão pressórica e discussão da balança decisional.

Caso Clínico 5: Suspeita de Tuberculose Pulmonar e Manejo do Estigma Familiar

• **Cenário:** Dona Marinalva, 44 anos, cozinheira em escola comunitária, comparece com tosse produtiva arrastada e febre baixa vespertina.

Aplicação dos 7 Passos:

1. Passo 1 (Preparação): O médico lê a ficha de acolhimento preenchida pela enfermagem: tosse há 4 semanas, perda de peso não intencional de 5 kg. Classificada como Sintomática Respiratória (SR). O médico prepara máscara cirúrgica para a paciente e máscara N95/PFF2 para si, assegurando o arejamento natural do gabinete (janelas abertas).

2. Passo 2 (Primeiros Minutos): Cumprimento acolhedor e seguro. O médico percebe o constrangimento de Marinalva ao tossir: *"Dona Marinalva, vejo que a senhora está incomodada com essa tosse. Coloquei essa máscara na senhora e em mim não por medo, mas por cuidado e respeito com a nossa saúde enquanto conversamos. Fique tranquila"*. Acolhimento do motivo: tosse com catarro amarelado e suores à noite.

3. Passo 3 (Exploração): Quadro arrastado há 1 mês, acompanhado de adinamia e febre no final da tarde. Nega hemoptise. Investigação de contatos: mora com o marido e duas filhas adolescentes. SIFE:

– *Sentimentos:* Vergonha e pavor da reação dos pais dos alunos da escola onde cozinha.

– *Ideias:* Acha que pegou "tísica" (tuberculose) no transporte público lotado.

– *Função:* Cansaço para cozinhar; isolou-se das filhas em casa com medo de contaminá-las.

– *Expectativas:* Queria saber se precisará ser internada longe da família.

– *Exame Físico:* Emagrecida, afebril no momento. Ausculta com estertores subcrepitantes em ápice pulmonar direito.

4. Passo 4 (Avaliação): O médico compartilha a suspeita clínica fundamentada de Tuberculose Pulmonar Ativa, desmistificando o estigma histórico da doença: explica que hoje o tratamento é 100% ambulatorial, gratuito pelo SUS, realizado em casa, e que a transmissão é interrompida em cerca de 15 dias após o início dos remédios adequados.

5. Passo 5 (Plano de Cuidados):

– Coleta imediata da 1ª amostra de escarro na unidade para realização do Teste Rápido Molecular para TB (TRM-TB) e fornecimento de frasco para coleta da 2ª amostra matinal;

– Solicitação de Radiografia de Tórax em regime de prioridade na rede básica;

– Oferta do Teste Rápido para HIV (pactuado e realizado com consentimento);

– Orientação sobre etiqueta respiratória no domicílio (dormir em quarto arejado enquanto aguarda o resultado);

– Planejamento de convocação dos contatos domiciliares para rastreamento de ILTB se confirmada a doença.

6. Passo 6 (Encerramento):

– *Teach-back:* A paciente explica como coletará o escarro ao acordar antes de escovar os dentes e trazê-lo à unidade.

– *Rede de segurança:* Alerta sobre sinais de gravidade (falta de ar intensa ou expectoração com sangue vivo - hemoptise volumosa). Retorno marcado para 48h para checagem do TRM-TB.

7. Passo 7 (Reflexão Final): O médico preenche o ReSOAP, sinaliza a ficha de notificação provisória no SINAN e reflete sobre o papel essencial da empatia na quebra do preconceito secular associado à tuberculose.

Registro ReSOAP:

• **S:** Cozinheira escolar, 44 anos. Tosse produtiva diária há 4 semanas, associada a sudorese noturna profusa, astenia e perda de 5 kg. Nega hemoptise ou comorbidades prévias. SIFE: S- Vergonha social e medo do estigma no emprego; I- Suspeita de tuberculose adquirida em ônibus; F- Afastada do convívio familiar íntimo por medo; E- Receio de internação em sanatório.

• **O:** Emagrecida (IMC = 19,4 kg/m²). Ausculta respiratória com murmúrio diminuído e estertores crepitantes no terço superior de hemitórax direito. Ausculta cardíaca normal. Teste Rápido HIV: Não reagente.

• **A:** Sintomática respiratória / Suspeita clínica de Tuberculose Pulmonar ativa.

• **P:**

• *Diagnóstico:* Coletada 1ª amostra de escarro para TRM-TB hoje. Entregue pote para 2ª amostra matinal. Solicitada Radiografia de tórax PA/Perfil em caráter de urgência ambulatorial.

• *Terapêutico:* Orientações de repouso e hidratação. Manter afastamento laboral provisório por atestado até o resultado microbiológico.

• *Seguimento:* Retorno agendado em 48h para resultado do TRM-TB e início de esquema RHZE se confirmado.

• *Educativo/Rede de Segurança:* Esclarecida a forma de transmissão aerógena e a importância da ventilação domiciliar; alertados sinais de alarme respiratório.

Caso Clínico 6: Investigação de Astenia e Hipotireoidismo Subclínico na Mulher Adulta

• **Cenário:** Patrícia, 42 anos, professora universitária, procura a UBS queixando-se de cansaço extremo, pele seca e dificuldade de concentração para corrigir trabalhos acadêmicos.

Aplicação dos 7 Passos:

1. Passo 1 (Preparação): O médico de família acessa o prontuário: paciente com histórico de infertilidade prévia resolvida, sem outras doenças crônicas. O médico organiza o birô de atendimento e prepara o estadiômetro e a balança.

2. Passo 2 (Primeiros Minutos): Acolhimento amável e sem pressa. Patrícia expressa sua exaustão: *"Doutor, acho que estou entrando em depressão ou com a tireoide destruída. Minha irmã tem Hashimoto e me disse que meus sintomas são idênticos aos dela"*. O médico esgota a agenda e pactua focar na fadiga e no rastreamento metabólico.

3. Passo 3 (Exploração): Ganho ponderal de 4 kg em 3 meses sem mudança dietética, constipação intestinal (evacuação a cada 4 dias) e sensibilidade exagerada ao ar-condicionado da faculdade. SIFE:

– *Sentimentos:* Frustração e medo de perder a produtividade intelectual na carreira docente.

– *Ideias:* Certeza convicta de que está com a Doença de Hashimoto da irmã.

– *Função:* Esquecimentos frequentes, lentificação para redigir artigos.

– *Expectativas:* Desejo de solicitar ultrassonografia da tireoide e dosagem completa de hormônios.

– *Exame Físico:* Pele seca, reflexo aquileu com fase de relaxamento nitidamente lentificada. Palpação tireoidiana: glândula de volume habitual, consistência fibroelástica homogênea, indolor, sem nódulos palpáveis.

4. Passo 4 (Avaliação): O médico explica que o exame físico não revela bócio ou nódulos anatômicos, tornando o ultrassom desnecessário neste momento. Explica o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide com clareza, pontuando que o diagnóstico funcional da tireoide é essencialmente laboratorial sanguíneo através do TSH e do T4 Livre.

5. Passo 5 (Plano de Cuidados):

– Solicitação criteriosa de exames: TSH, T4 Livre, Hemograma completo (afastar anemia ferropriva) e Anticorpos Anti-TPO;

– Desmistificação sobre o uso de "fórmulas milagrosas de iodo" vistas na internet;

– Orientações gerais de hidratação cutânea e aumento do consumo de fibras para a constipação.

6. Passo 6 (Encerramento):

– *Teach-back:* Patrícia resume com clareza quais exames de sangue fará no laboratório da UBS e compreende por que o ultrassom seria um gasto inútil e iatrogênico agora.

– *Rede de segurança:* Se notar surgimento de nódulo visível no pescoço ou prostração grave, contatar a unidade. Retorno em 15 dias com os resultados.

7. Passo 7 (Reflexão Final): Registro no ReSOAP, autorreflexão sobre como foi importante validar a história familiar sem capitular à solicitação acrítica de exames de imagem que apenas gerariam ansiedade.

Registro ReSOAP:

• **S:** Professora, 42 anos. Astenia progressiva há 3 meses, associada a lentificação cognitiva, intolerância ao frio, obstipação e ganho ponderal de 4 kg. Histórico familiar de tireoidite de Hashimoto na irmã. SIFE: S- Ansiedade com rendimento acadêmico; I- Crença de ter hipotireoidismo de Hashimoto; F- Dificuldade de escrita e concentração profissional; E- Pedia ultrassom e painel hormonal amplo.

• **O:** Bom estado geral, afebril, corada. Pele áspera em membros. Tireoide palpável, não aumentada, indolor, sem nódulos. Reflexo aquileu com tempo de relaxamento lentificado. PA = 118/76 mmHg, FC = 56 bpm.

• **A:**

1. Síndrome de astenia crônica a esclarecer;

2. Suspeita clínica de Hipotireoidismo primário (etiologia autoimune provável);

3. Constipação funcional secundária.

• **P:**

• *Diagnóstico:* Solicitar dosagem sérica de TSH, T4 Livre, Anti-TPO e Hemograma completo. Esclarecida a desnecessidade de ultrassonografia cervical.

• *Terapêutico:* Orientações dietéticas com estímulo à ingestão hídrica e fibras solúveis/insolúveis.

• *Seguimento:* Retorno agendado em 2 semanas com os laudos laboratoriais para definição de conduta medicamentosa (Levotiroxina se indicada).

• *Rede de segurança:* Orientados sintomas de alerta e disponibilidade da equipe da UBS.

Caso Clínico 7: Comunicação de Más Notícias (Protocolo SPIKES) na APS

• **Cenário:** Seu Antenor, 67 anos, tabagista de longa data, retorna à UBS para saber o resultado da biópsia de uma lesão ulcerada indolor em borda lateral de língua que não cicatrizava há 2 meses.

Aplicação dos 7 Passos e Protocolo SPIKES:

1. Passo 1 (Preparação / S - Setting up): O médico de família analisa o laudo anatomopatológico chegado do serviço de referência: *Carcinoma Espinocelular (CEC) invasor*. O médico suspende qualquer interrupção, desliga o interfone, organiza lenços de papel na mesa e prepara seu estado emocional para transmitir a notícia mais difícil da vida daquele paciente.

2. Passo 2 (Primeiros Minutos): Cumprimenta Seu Antenor e pergunta se ele gostaria que a esposa, que aguardava do lado de fora, entrasse para acompanhar a conversa. O paciente prefere que ela participe. Ambos se sentam.

3. Passo 3 (Exploração / P - Perception e I - Invitation):

– *Perception: "Seu Antenor, o que o senhor se lembra da nossa última consulta quando realizamos a pequena biópsia da sua língua?"*. Paciente: *"O senhor me disse que aquela ferida não era afta comum e que precisávamos tirar um pedacinho para ver se era algo ruim"*.

– *Invitation: "O senhor é do tipo de pessoa que prefere saber todos os detalhes do resultado ou prefere que conversemos de forma mais geral sobre o tratamento?"*. Paciente: *"Doutor, pode me falar a verdade inteira. Eu prefiro saber exatamente o que tenho"*.

4. Passo 4 (Avaliação / K - Knowledge): O médico comunica a notícia com delicadeza, em pequenos blocos, usando aviso prévio (*warning shot*): *"Seu Antenor, infelizmente o exame daquele pedacinho da língua confirmou o que nós temíamos. A ferida é um tumor maligno, um câncer na língua"*. O médico faz uma pausa de silêncio funcional, mantendo contato visual afetuoso.

5. Passo 5 (Plano de Cuidados / E - Emotions e S - Strategy):

– *Emotions:* O paciente começa a chorar silenciosamente e a esposa segura sua mão em choque. O médico valida a dor: *"Eu sei o quanto ouvir isso assusta e dói. É perfeitamente natural sentir esse chão sumir agora. Mas quero que os senhores saibam que nós não vamos soltar a mão de vocês em nenhum momento"*;

– *Strategy:* Após a estabilização emocional, o médico detalha o plano de ação: encaminhamento imediato via sistema de regulação de oncologia de cabeça e pescoço, solicitação de exames pré-operatórios básicos e marcação de suporte psicológico na UBS.

6. Passo 6 (Encerramento):

– *Teach-back:* Checagem sobre o entendimento dos próximos passos: o paciente expressa que sabe que precisará de cirurgia e que o médico da UBS continuará sendo sua referência.

– *Rede de segurança:* Telefone direto da equipe de enfermagem da família fornecido para qualquer dúvida nos próximos dias. Retorno semanal de suporte pactuado.

7. Passo 7 (Reflexão Final): O médico preenche o ReSOAP, anota a nota prospectiva para acompanhar a regulação no SISREG e dedica 3 minutos para respirar e processar a carga emocional do encontro, reconhecendo o valor do acolhimento humano na dor do outro.

Registro ReSOAP:

• **S:** Aposentado, 67 anos, comparece acompanhado da esposa para ciência de laudo anatomopatológico de lesão em língua. SIFE: S- Choque inicial, angústia e choro contido; I- Compreensão de gravidade; F- Preocupação com a esposa e sobrevida; E- Desejo de iniciar o tratamento cirúrgico o mais rápido possível.

• **O:** Emocionalmente abalado, choro durante a sessão. Lesão ulcerada endurecida em borda lateral esquerda de língua com cerca de 1,8 cm. Laudo Histopatológico: Carcinoma Epidermoide (Espinocelular) invasor de cavidade oral.

• **A:** Carcinoma de células escamosas de língua (CID C02.1) recém-diagnosticado / Comunicação de más notícias via SPIKES.

• **P:**

• *Terapêutico:* Acolhimento empático com suporte à reação aguda ao estresse. Inserção prioritária no Sistema de Regulação Estadual de Oncologia de Cabeça e Pescoço.

• *Diagnóstico:* Solicitação de Raio-X de tórax e exames laboratoriais pré-operatórios de rotina enquanto aguarda o agendamento oncológico.

• *Seguimento:* Consulta presencial na próxima semana na UBS para acompanhamento do encaminhamento e suporte psicossocial.

• *Educativo/Rede de Segurança:* Entregue contato direto da equipe de Saúde da Família e pactuado plano de proteção emocional familiar.

Caso Clínico 8: O Paciente Jovem com Sintomas Inespecíficos e Risco de Sobrediagnóstico

• **Cenário:** Lucas, 23 anos, estudante de direito, comparece apreensivo por causa de "episódios de tontura e palpitações" que começaram há 3 semanas após ler tópicos na internet.

Aplicação dos 7 Passos:

1. Passo 1 (Preparação): O médico verifica no prontuário: jovem sem histórico de doenças crônicas, sem uso de medicamentos contínuos, com histórico de visita prévia ao pronto-socorro com ECG normal. Médico prepara-se para acolher sem rotular apressadamente como "apenas ansiedade".

2. Passo 2 (Primeiros Minutos): Lucas entra agitado, segurando anotações no celular. O médico acolhe com atenção plena e escuta aberta: *"Lucas, vejo que você preparou anotações para a consulta. Me conte o que tem acontecido com calma"*. Lucas relata que sente o coração disparar do nada e a cabeça flutuar, achando que tem arritmia cardíaca grave.

3. Passo 3 (Exploração): Os episódios ocorrem geralmente na biblioteca da faculdade ou ao dirigir para o estágio. Duram cerca de 15 minutos e são acompanhados de formigamento nas mãos, sensação de falta de ar e medo de desmaiar. Nega síncope verdadeira, dor no peito ou histórico familiar de morte súbita em jovens. SIFE:

– *Sentimentos:* Pânico constante de sofrer uma parada cardíaca súbita.

– *Ideias:* Acha que tem Síndrome de Brugada ou feocromocitoma porque leu sobre isso em um fórum médico.

– *Função:* Deixou de ir às aulas presenciais e evita dirigir na rodovia.

– *Expectativas:* Queria que o médico pedisse um Holter de 24 horas, Ecocardiograma e uma tomografia de crânio.

– *Exame Físico:* Completamente normal. PA = 120/78 mmHg, FC = 78 bpm, sem sopros, pulsos cheios e simétricos, tireoide normal, ausculta pulmonar límpida.

4. Passo 4 (Avaliação): O médico de família desconstrói o pânico conectando os pontos: explica a fisiologia da crise de ansiedade e ataque de pânico. Demonstra como a hiperventilação na crise reduz o gás carbônico no sangue, provocando a vasoconstrição cerebral benigna que causa a tontura e o formigamento nas mãos, sem que haja nenhuma doença orgânica no coração.

5. Passo 5 (Plano de Cuidados):

– Decisão compartilhada sobre não solicitar exames cardiológicos invasivos neste momento, pois a probabilidade pré-teste de cardiopatia estrutural é praticamente nula e os exames aumentariam o foco na doença (reforço da ansiedade por somatização);

– Ensino de manobras de respiração diafragmática para controle das crises de hiperventilação;

– Encaminhamento para apoio psicoterápico focado em Terapia Cognitivo-Comportamental;

– Redução drástica do consumo de energéticos e café (Lucas bebia 6 xícaras de café por dia).

6. Passo 6 (Encerramento):

– *Teach-back:* Lucas descreve como a respiração lenta atua no controle da tontura e valida que compreendeu que seu coração é jovem e saudável.

– *Rede de segurança:* Caso sinta desmaio com perda de consciência ou palpitação associada a dor torácica opressiva, retornar de pronto. Retorno em 3 semanas.

7. Passo 7 (Reflexão Final): O médico registra o ReSOAP e reflete sobre como a explicação fisiopatológica empática da ansiedade preveniu a espiral de exames e a iatrogenia médica no jovem.

Registro ReSOAP:

• **S:** Estudante, 23 anos. Queixa de crises paroxísticas de palpitação, tontura não rotatória, parestesia em mãos e sensação de asfixia há 3 semanas, desencadeadas em ambientes de estudo e trânsito. Nega síncope ou história familiar de morte súbita. Consumo excessivo de café (6 xícaras/dia) e uso de energéticos. SIFE: S- Pânico de parada cardíaca; I- Crença em arritmia congênita rara vista na internet; F- Evasão de aulas e bloqueio para dirigir; E- Solicitação de Holter e Tomografia.

• **O:** Bom estado geral, ansioso. PA = 120/78 mmHg, FC = 78 bpm. Eletrocardiograma de repouso trazido do PS com ritmo sinusal estrito normal. Exame físico segmentar cardiovascular e neurológico sem anormalidades.

• **A:**

1. Transtorno de Pânico / Crises de ansiedade paroxística com hiperventilação;

2. Uso excessivo de substâncias estimulantes (cafeína/energéticos);

3. Risco de iatrogenia diagnóstica por excesso de exames de baixa especificidade.

• **P:**

• *Terapêutico:* Psicoeducação sobre o ciclo pânico-hiperventilação-alcalose respiratória. Prescrição comportamental: suspensão imediata de energéticos e redução gradual do café. Treinamento de respiração lenta diafragmática nas crises. Encaminhamento para psicoterapia na rede.

• *Diagnóstico:* Pactuada a não realização de exames complementares adicionais no momento.

• *Seguimento:* Retorno agendado em 3 semanas para reavaliação clínica do diário de sintomas.

• *Rede de segurança:* Esclarecidos sinais de alerta cardiológico verdadeiro.

Caso Clínico 9: A Consulta de Pré-Natal e o Compartilhamento de Decisões na Gravidez

• **Cenário:** Camila, 28 anos, primigesta na 14ª semana de gestação, comparece com o parceiro Felipe para consulta de pré-natal de risco habitual.

Aplicação dos 7 Passos:

1. Passo 1 (Preparação): O médico revisa os exames de 1º trimestre anexados: tipagem O positivo, sorologias negativas para HIV, Sífilis e Hepatite B, imune à rubéola e toxoplasmose não reagente. Médico organiza a fita obstétrica e o sonar Doppler.

2. Passo 2 (Primeiros Minutos): Cumprimenta o casal pelo nome, estabelece um ambiente de alegria e tranquilidade: *"Camila e Felipe, que alegria recebê-los hoje para acompanhar a evolução do bebê. Como têm sido essas últimas semanas?"*. Esgotamento de dúvidas e sintomas.

3. Passo 3 (Exploração): Camila relata que os enjoos diminuíram muito, mas que Felipe está angustiado com uma matéria que leu dizendo que o parto normal causa sofrimento desnecessário e quer agendar cesariana no setor privado. SIFE do casal:

– *Sentimentos:* Insegurança e medo da dor do parto por parte de ambos.

– *Ideias:* Acreditavam que a cesariana programada é mais "controlada e segura para a criança".

– *Função:* Felipe perde o sono pesquisando complicações de parto na internet.

– *Expectativas:* Esperavam que o médico já marcasse a data da cesárea.

– *Exame Físico:* Ganho ponderal adequado, PA = 110/70 mmHg, Altura Uterina = 14 cm, Batimentos Cardiofetais (BCF) audíveis ao Doppler com 144 bpm, nítidos. O casal emociona-se ao ouvir o coração do bebê.

4. Passo 4 (Avaliação): O médico compartilha a excelente evolução do pré-natal: gestação de baixo risco com parâmetros materno-fetais ideais. Utiliza o momento para discutir ciência e evidências sobre as vias de parto, explicando os benefícios respiratórios e imunológicos do parto normal para o recém-nascido e a recuperação mais rápida da mulher, sem desqualificar o medo da dor sentido pelo casal.

5. Passo 5 (Plano de Cuidados):

– Pactuação de plano de parto gradual: inclusão do casal nas oficinas de gestantes da UBS com a equipe de enfermagem para conhecer métodos não farmacológicos de alívio da dor (massagens, banho morno, bola de pilates);

– Visita guiada à maternidade de referência regional para conhecer a sala de parto humanizado;

– Prescrição preventiva: Sulfato Ferroso e Ácido Fólico mantidos; atualização da vacina contra Difteria, Tétano e Coqueluche (dTpa) agendada para a 20ª semana;

– Orientações sobre profilaxia para toxoplasmose (higienização de alimentos e evitar contato com fezes de felinos).

6. Passo 6 (Encerramento):

– *Teach-back:* Felipe e Camila explicam como higienizarão os vegetais crus e confirmam a data da visita à maternidade, expressando que se sentem muito mais calmos e desmistificados.

– *Rede de segurança:* Sangramento vaginal, perda de líquido ou contrações ritmadas devem levar à maternidade de referência. Retorno pré-natal agendado para 4 semanas.

7. Passo 7 (Reflexão Final): O médico anota a evolução completa na Caderneta da Gestante e no prontuário eletrônico ReSOAP, registrando com satisfação como a escuta ativa do pai fortaleceu o envolvimento paterno e a tomada de decisão compartilhada informada.

Registro ReSOAP:

• **S:** Primigesta, 28 anos, IG: 14 semanas por USG de 1º trimestre, comparece com o esposo. Refere melhora das náuseas matinais, queixa de lombalgia postural discreta. Esposo manifesta insegurança com a via de parto normal e desejo de cesárea eletiva. SIFE: S- Ansiedade com o trabalho de parto; I- Crença de que a cesariana previne sofrimento fetal; F- Sono intranquilo do casal; E- Pedido de agendamento cirúrgico precoce.

• **O:** Bom estado geral, corada, hidratada. Peso: 62 kg (ganho de 2 kg no trimestre). PA = 110/70 mmHg. Abdome: AU = 14 cm, BCF = 144 bpm regulares. Sem edema em membros inferiores. Exames de rotina do 1º trimestre conferidos e todos normais/imunes.

• **A:** Gestação tópica única de 14 semanas em pré-natal de risco habitual / Demanda de decisão informada sobre via de parto.

• **P:**

• *Terapêutico:* Manter Suplementação com Sulfato Ferroso 40 mg de ferro elementar/dia. Prescrição de atividades de alongamento e caminhada leve.

• *Educativo:* Diálogo compartilhado sobre vias de parto baseado em evidências. Inscrição do casal no Grupo de Preparação para o Parto da UBS e agendamento de visita à maternidade pública de referência.

• *Seguimento:* Próxima consulta de pré-natal em 4 semanas.

• *Rede de segurança:* Orientados sinais de alerta obstétrico (sangramento, perda de líquido, cefaleia refratária).

Caso Clínico 10: O Paciente Poliqueixoso com Sintomas Medicamente Inexplicáveis

• **Cenário:** Dona Cleusa, 49 anos, trabalhadora do comércio, comparece pela quinta vez no semestre à UBS trazendo uma sacola com exames laboratoriais e radiografias, todas com laudos rigorosamente normais, queixando-se de que "o corpo inteiro dói e nenhum médico descobre o que ela tem".

Aplicação dos 7 Passos:

1. Passo 1 (Preparação): O médico de família analisa a densa linha do tempo de Cleusa: múltiplos médicos já a atenderam, sempre solicitando novos exames de sangue e ressonâncias, gerando rotulações pejorativas no prontuário ("poliqueixosa", "somatizadora"). O médico reconhece o sentimento de frustração que esse histórico costuma despertar na equipe e prepara sua mente para o acolhimento sem julgamento, disposto a ouvir a pessoa por trás dos exames.

2. Passo 2 (Primeiros Minutos): Cumprimento afetuoso. O médico repara que Cleusa já entra na defensiva, esperando ser dispensada rapidamente: *"Dona Cleusa, por favor, sente-se. Eu estive olhando seu prontuário e vejo que a senhora tem passado por dias muito difíceis, com consultas frequentes. Quero que saiba que hoje reservei esse tempo exclusivamente para ouvi-la de verdade"*. Cleusa chora instantaneamente, desarmando sua postura defensiva.

3. Passo 3 (Exploração): Cleusa relata dores difusas em queimação nos ombros, costas e quadris há mais de um ano, associadas a acordar com a sensação de não ter dormido nada, dores de cabeça tensionais e cólicas abdominais frequentes. SIFE:

– *Sentimentos:* Solidão profunda, sensação de rejeição e desespero por achar que ninguém acredita na sua dor.

– *Ideias:* Acha que tem uma doença degenerativa rara ou um reumatismo silencioso que os exames de sangue não conseguem pegar.

– *Função:* Não consegue brincar com os netos e vive em atrito com o marido, que diz que "a dor é frescura da cabeça dela".

– *Expectativas:* Esperava que o médico pedisse mais uma ressonância ou a encaminhasse para um especialista em hospital terciário.

– *Exame Físico:* Ausência de sinovite articular, sem edema ou deformidades. Presença de dor intensa à palpação digital em mais de 12 dos 18 pontos anatômicos sensíveis (*tender points*) clássicos bilaterais (critérios para Fibromialgia / Síndrome de Sensibilização Central).

4. Passo 4 (Avaliação): O médico promove a virada clínica terapêutica através da validação da dor: *"Dona Cleusa, a primeira coisa que quero lhe dizer com toda a certeza é: a sua dor é real. A senhora não está inventando nada e isso não é frescura"*. O médico explica o conceito da **Fibromialgia** e da sensibilização central: utiliza a metáfora do "botão do volume do som" do cérebro, que está regulado no volume máximo para a dor, explicando por que os exames de sangue e de imagem são normais — a doença é na regulação dos sinais nervosos, e não uma destruição do osso ou junta.

5. Passo 5 (Plano de Cuidados):

– Suspensão imediata de novas solicitações de exames de imagem desnecessários (interrupção do ciclo iatrogênico);

– Tratamento não farmacológico (pilar essencial): prática de atividade física aeróbica de baixo impacto (iniciar com caminhadas diárias de 15 minutos) e higiene do sono rigorosa;

– Início de tratamento farmacológico focado na dor neuropática/sensibilização central com antidepressivo modulador da dor (Duloxetina ou Amitriptilina em dose baixa inicial);

– Convocação do marido para uma consulta conjunta na próxima semana para psicoeducação familiar sobre a legitimidade da fibromialgia.

6. Passo 6 (Encerramento):

– *Teach-back:* A paciente explica que compreendeu que a doença não vai deformar seus ossos e que o exercício físico é o remédio mais potente para rebaixar o volume da dor no cérebro.

– *Rede de segurança:* Orientados sintomas de alerta e garantido o seguimento com o mesmo médico da família. Retorno agendado para 20 dias.

7. Passo 7 (Reflexão Final): O médico preenche o ReSOAP, consolida a lista de problemas retirando termos vagos e registrando "Fibromialgia", refletindo sobre como a escuta empática e a validação do sofrimento operaram a verdadeira cura relacional após anos de peregrinação inútil pelo sistema.

Registro ReSOAP:

• **S:** Comerciária, 49 anos. Peregrinação clínica em múltiplos serviços com história de dor crônica generalizada há mais de 14 meses, acompanhada de sono não reparador, fadiga diurna e cefaleia tensional. Traz múltiplos exames normais. SIFE: S- Tristeza profunda, incompreensão e abandono conjugal; I- Acha que tem doença rara incurável invisível nos exames; F- Incapaz de realizar tarefas domésticas e brincar com os netos; E- Pede nova bateria de exames de imagem e encaminhamento.

• **O:** Bom estado geral, choro copioso durante a narrativa. Exame osteoarticular sem calor, rubor ou derrames articulares. Dor evidente à palpação de pontos gatilho bilaterais em trapézio, segunda costela, epicôndilo lateral, glúteo e joelho (> 12 pontos positivos).

• **A:**

1. Síndrome de Fibromialgia / Síndrome de Sensibilização Central Crônica;

2. Sono não reparador secundário;

3. Sofrimento psicossocial por incompreensão familiar e peregrinação no sistema de saúde.

• **P:**

• *Terapêutico:* Validação diagnóstica da dor. Introdução de Amitriptilina 25 mg VO à noite para ajuste do sono e modulação de dor. Prescrição comportamental de caminhadas leves graduais.

• *Diagnóstico:* Suspensão de exames subsidiários adicionais; pactuada a desnecessidade de novos laudos.

• *Seguimento:* Retorno agendado em 3 semanas. Convocação do esposo para consulta educativa sobre a doença.

• *Educativo/Rede de Segurança:* Entregue material explicativo sobre o manejo não farmacológico da fibromialgia e estabelecido canal de segurança com a UBS.

9. Considerações Finais: A Consulta como Espaço de Cura e Cidadania

A Consulta Médica em 7 Passos transcende a condição de simples manual procedimental para se firmar como um tratado ético, epistemológico e humanístico no coração dos sistemas de saúde universais. Em um tempo marcado pela crescente fragmentação superespecializada, pela dependência acrítica de tecnologias duras e pelo perigo da medicalização excessiva da vida cotidiana, o retorno ao encontro entre duas pessoas — mediado pela presença atenta, pela escuta qualificada e pela decisão compartilhada — constitui o mais potente instrumento terapêutico da medicina.

A verdadeira excelência clínica não reside na velocidade com que se preenche um prontuário ou na quantidade de fármacos prescritos ao final de um turno extenuante, mas na capacidade permanente de olhar para cada ser humano na sua irrepetível singularidade, construir pontes de entendimento e esperança onde havia solidão e sofrimento, e transformar a consulta médica em um ato duradouro de acolhimento, cuidado e emancipação social.